业财融合视域下
卫生健康经济管理人才培养
调查分析报告

162份答卷的完整重算与证据复核

研究对象：受访者本人特征、所在机构培养现状、能力与课程需求、实践路径及保障机制。

本报告面向人才培养项目设计与管理决策。问卷显示数智与业务能力培养需求突出，跟岗、项目与案例学习具有较高偏好；落实制度、过程跟踪及成果运用仍存在改进空间。所有结论均限定于本次答卷，不等同于独立医院调查或全国总体估计。

分析日期 2026年10月17日

公开汇总版 不含原始答卷、个人标识、IP、逐人时间或可识别开放原文

基于原始两份Excel重新计算。本版独立生成，不宣称恢复此前无法取得的报告二进制文件。

阅读导航

一 主要结论与决策含义

二 数据基础与分析方法

三 受访者结构与机构培养现状

四 复合能力差距与人才需求

五 培养方式及课程供需

六 组织保障与成果转化

七 探索性比较与不确定性

八 人员结构选答的专门核验

九 稳健性与旧结论检查

十 可执行建议与后续研究

附录A 47题完整统计

附录B 完整比较与追溯说明

使用顺序：先看主要结论，再查看对应原题和分母；需要引用数值时以本报告与配套统计工作簿同口径结果为准。附件代码可在本地读取原始输入后重新产生公开聚合结果。

一 主要结论与决策含义

最明确的需求是数智课程与业务实践的结合。Q26数智化运营与数据分析必要程度达到4至5分的有156/162份（96.3%），但Q17报告已有信息化与数据工具培训的仅49/162份（30.2%）。同一答卷中同时满足高需求且未勾选现有供给的有109份，占全样本67.3%，占高需求者69.9%。两个题项概念接近但不完全相同，不能直接解释为109家医院完全没有数据培训。

当前能力差距呈现业务、数据与管理相对突出，财务相对较小的格局。业务高差距66份（40.7%），数据57份（35.2%），财务42份（25.9%）。业务与数据的配对差异未获得明确统计支持，不能把两者机械排序为显著不同的优先级。

问题	证据	决策含义
人才供需	未来需求前三：运营133、数据120、综合89份	用运营项目承载数据与业务课程，兼顾综合协调
实践方式	跟岗前三125、项目95、案例90份	优先试点可交付真实成果的实践组合
过程管理	缺跟踪108份；分层不足82份	加入阶段复盘与分层任务设计
成果转化	实践机会不足126份；激励障碍96份	设置真实项目入口及结果运用机制
制度关联	制度落实组无评估9/32，其他组76/130	将制度建设与实际评价工具同时推进

这些结果支持“优先试点什么”，尚不能证明“某种培养方式最有效”。偏好、必要性与现有供给属于不同测量对象；有效性需要培训前后指标、对照或分阶段实施评价。

需要保留的三条边界

第一，162份答卷不等于162家独立医院，缺少医院唯一标识，不能去重或处理院内聚类。第二，样本高度集中于三级类别与财审背景，基层覆盖不足。第三，Q11和Q12为选答，人数合计受异常大值、重复机构和填报口径影响，不构成可靠的独立人员样本。

二 数据基础与分析方法

原始数据为同一问卷的两个导出版本，均为Sheet1和162行。数值版207列，文本版129列，含47题。按答卷序号对齐后，对201个实质字段进行重建与交叉比较，共32562格一致。多选按文本选项拆解，排序按箭头顺序重建，单选按选项字母或是非标签重建。元数据和标识仅用于内部匹配，不进入公开附件。

参考PDF《高端会计人才项目在线学习情况调研报告》为另一项1495份答卷的调查，仅借鉴“ 样本画像—现状—需求—建议 ”的结构，不迁用其中任何样本数、比例或研究结论。本报告使用当前162份真实数据重新分析。

题型	处理规则	分母
单选与是非矩阵	按原始代码及文本标签汇总	本次均为162
多选题	每项单独计算选择人数；比例可累计超过100%	162
Q23 Q25 Q38前三排序	分别列第1、第2、第3名、首选率与前三率	162
五级量表	报告1至5分分布、均值、标准差、中位数及高低分率	各子项有效数，本次162
Q11 Q12人数选答	非负整数为有效；空白与非空无效分开	每字段自己的有效填报数
Q47开放题	12份实质意见，多主题编码，仅公开聚合	12份实质意见

统计推断与多重比较

二元比例采用Wilson 95%区间。探索性分组比较采用双侧Fisher精确检验，比例差采用Newcombe 95%区间。分别在医院类别12项、职务分组12项、制度落实3项与Q11可用性6项家族内实施Benjamini – Hochberg校正。正文和工作簿均保留未经校正p与校正q；95%区间未作多重性调整。

Q22同一受访者的五维差距采用Friedman检验，并报告Kendall W。10个维度对的均值差采用保留零差与并列的精确符号翻转置换检验，10对共同BH校正；均值差区间为配对t近似，仅辅助描述。此方法把五级评分视为近似等距，并要求零假设下差值可交换符号，解释时保留这一假设。

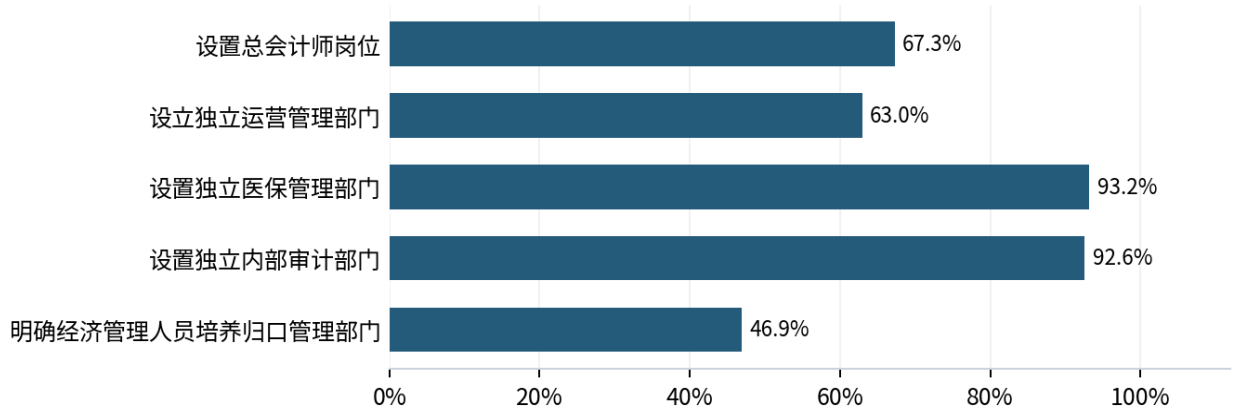
上述区间及检验是模型条件下的探索性描述。因抽样方式未证实为概率抽样、机构可能重复、医院聚类无法识别，它们不能修正代表性偏差，不能作为全国推断或因果证明。统计不显著也不等同于两组相同。

三 受访者结构与机构培养现状

变量	主要结果	含义与限制
医院类别	三级145/162（89.5%）；二级14/162（8.6%）；其他3/162	按原题编码，不将其他填报细节重新识别为医院
职务	院级领导6，总会计师14，部门正职41，副职30，其他71	管理者定义为Q4编码1至4，共91
年龄与学历	31至40岁99份；硕士88、本科70、博士3、大专及以下1	不能精确重建36至55岁年龄段
职称	正高级25、副高级50、中级83、初级及以下1、未评聘3	高级合计75/162（46.3%）
部门与专业	财务或审计部门109；财审专业142	部门归属与教育专业不可混用
地区构成	江苏38、河南33，合计71/162（43.8%）	统一省市后缀；不公开城市与个人组合

样本以具有较高学历的财审背景在职人员为主，适合识别这部分群体对业财融合培养的评价。与基层、初入职、非财审背景人员的需求差异尚需进一步补样。不能将受访者个人结构当作其所在医院全体经济管理人员的结构。

岗位与机构设置的报告比例



来源 Q10；每项分母162；1=是、2=否

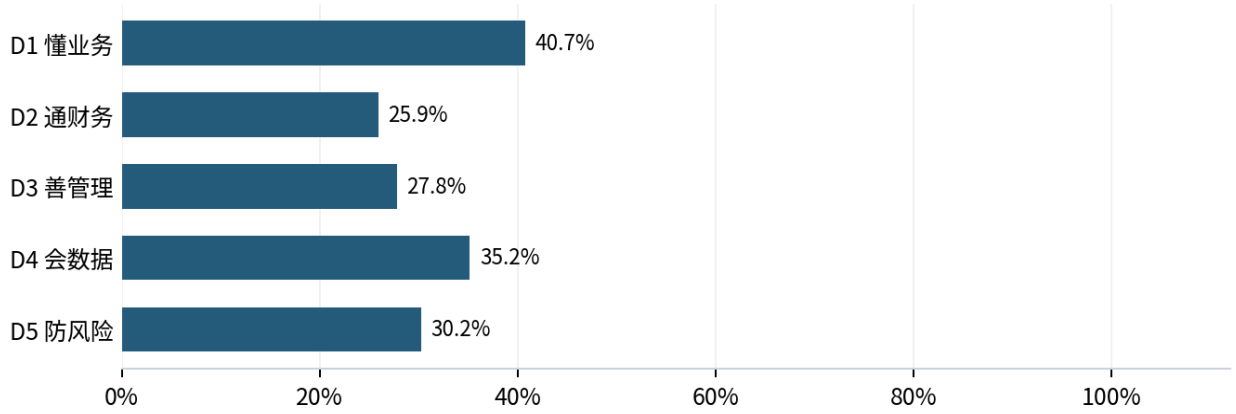
培养制度与资源投入

32/162份（19.8%）回答有制度且落实到位，49份（30.2%）有制度但落实不足，81份（50.0%）无系统制度安排。后两类共130份，需按其原始含义区分，不能全部称为无制度。

年人均培训学时在20学时以下与20至40学时两个档次的合计103份（63.6%）；年人均经费在1000元以下与1000至3000元档次合计110份（67.9%）。档位边界来自原题，不能用组中值反推精确平均学时或平均经费。人员配置严重不足或相对不足82份（50.6%），提示课程安排应与学习时间和人员替补安排结合。

四 复合能力差距与人才需求

五维能力高差距比例

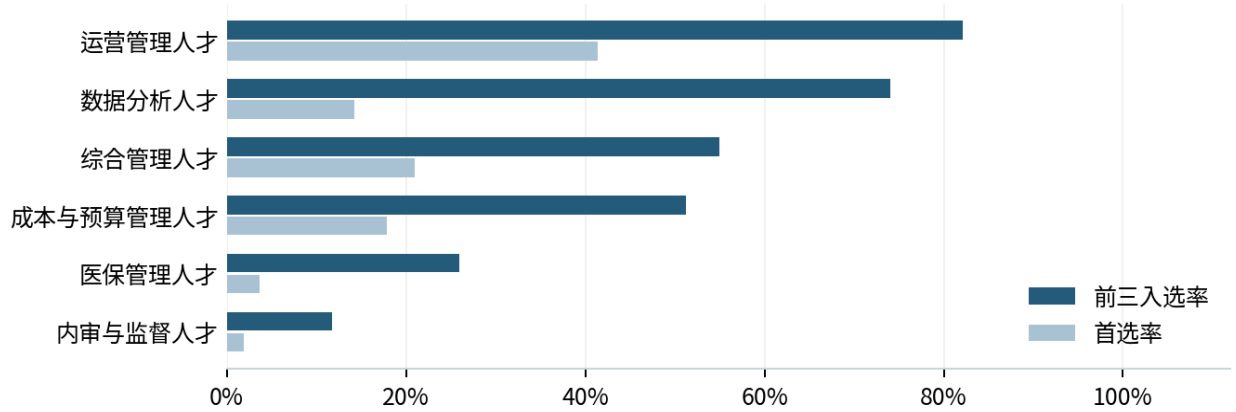


来源 Q22；4至5分表示差距较大；每项分母162

维度	均值	中位数	高差距 n/N	Wilson 95%区间
D1 懂业务	3.30	3	66/162	33.5% 至 48.4%
D2 通财务	2.66	3	42/162	19.8% 至 33.2%
D3 善管理	3.09	3	45/162	21.5% 至 35.1%
D4 会数据	3.13	3	57/162	28.3% 至 42.8%
D5 防风险	3.02	3	49/162	23.7% 至 37.7%

五维整体分布存在差异，Friedman统计量为66.65，p=1.16e-13，Kendall W=0.103。效应大小较有限，不能因p值很小就认为差距悬殊。业务与数据均应纳入课程优先议题；两者均值差0.173分，精确置换p=0.05049，10对BH q=0.07214，未形成明确区分证据。

未来三年人才需求排序

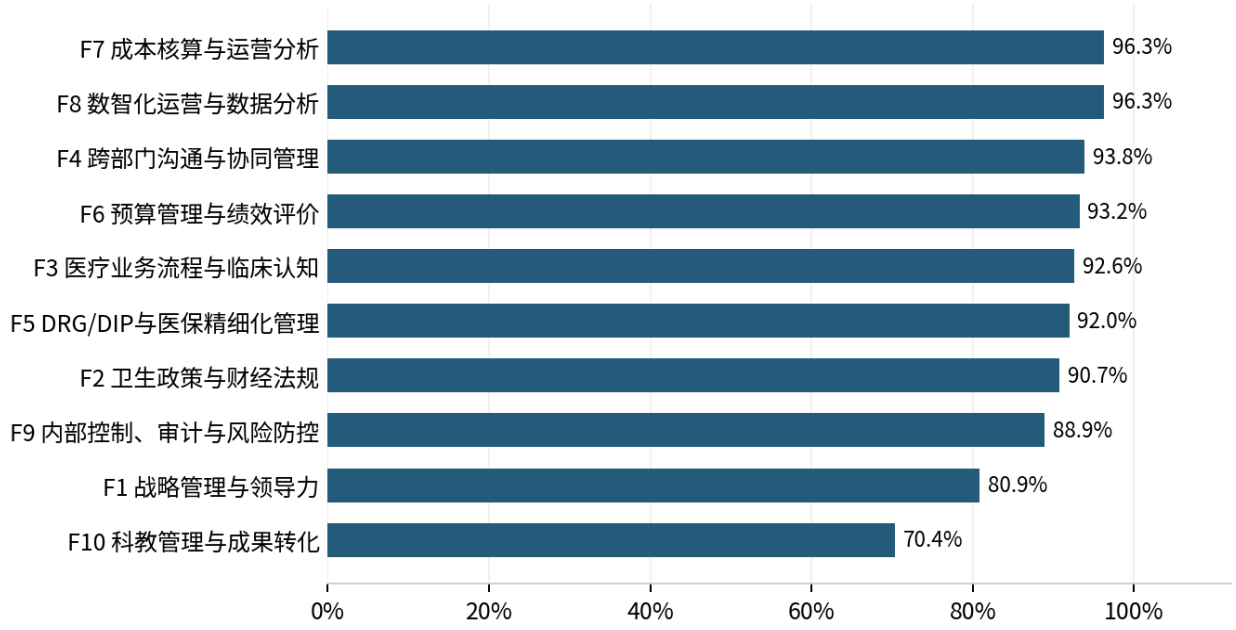


来源 Q23；同时呈现前三入选率与首选率；每项分母162

按前三入选，运营管理133份、数据分析120份、综合管理89份位列前三；成本与预算83份排第四。按首选，运营67份、综合34份、成本与预算29份位列前三。两套排名回答不同问题，不能交换。医保人才前三42份（25.9%），而医保课程高必要性149份（92.0%）；前者是有限名额下的相对人才需求排序，后者是绝对课程必要性，不能据此认定医保重要性被低估。

五 培养方式及课程供需

各课程模块的高必要性比例



来源 Q26；4至5分；每项分母162

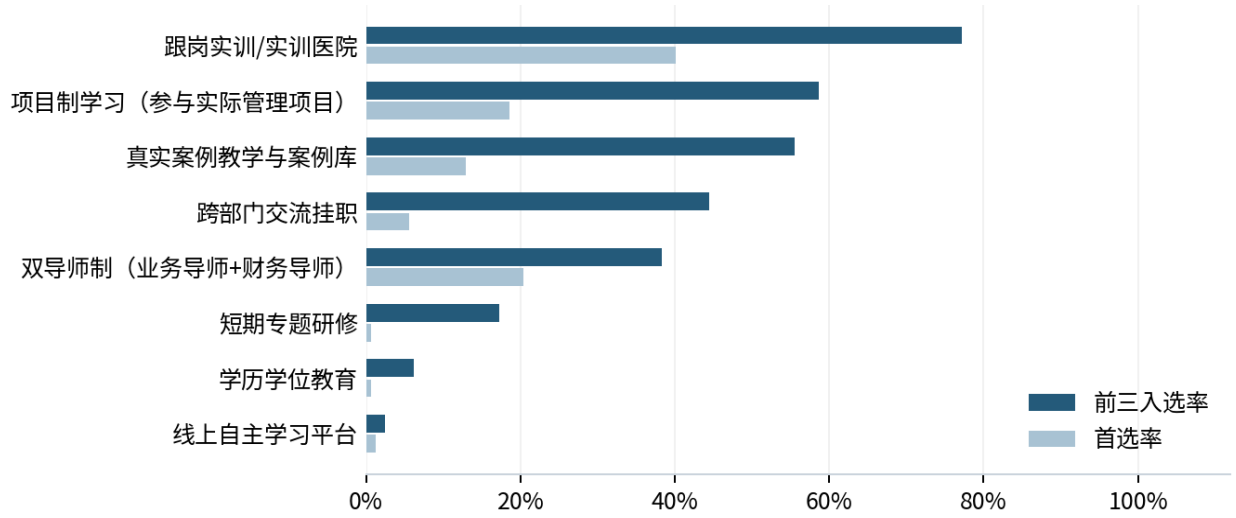
多项课程均呈现高必要性，说明培养需要兼顾业务理解、管理协同和数据方法。高认可可能受共同方法偏差或倾向性回答影响，单凭必要性打分难以决定课时分配；应结合岗位任务、现有基础与实践成果进行选择。

同一答卷的数智需求与供给	报告已有数据工具培训	未勾选现有培训	合计
数智高需求	47	109	156
非高需求	2	4	6
合计	49	113	162

109份“高需求且未勾选供给”是可优先跟进的需求信号。Q26涉及数智化运营与数据分析课程，Q17涉及信息化与数据工具，概念并不完全一致；现有培训还可能存在记忆遗漏。因此建议在课程试点前进行简短课程清单核对，而非直接认定供给空白。

培养方式偏好与可落地组合

培养方式的前三入选率与首选率



来源 Q25；每项分母162

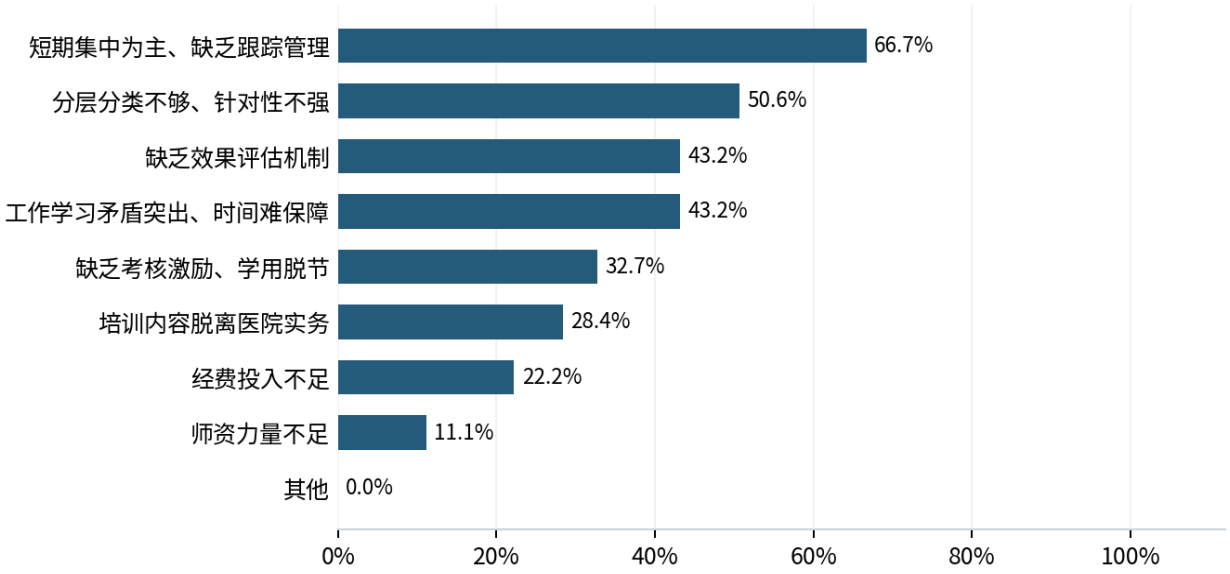
前三入选最普遍的方式是跟岗125份（77.2%）、项目95份（58.6%）和案例90份（55.6%）。双导师62份（38.3%）虽不是前三覆盖的前三项，但首选33份，仅次于跟岗65份，显示有一部分受访者将持续导师支持置于较高优先级。不能仅依据前三覆盖率否定导师制价值。

已有跟岗或轮岗培训方式70份（43.2%）；偏好跟岗且未报告现有相应方式72份（44.4%）。另一方面，双导师已实施仅7份，另有12份希望一年内启动、91份有意愿但条件暂不具备、52份暂无意愿。导师安排需要明确工作量、激励、业务导师与财务导师职责，而不能只列入课程方案。

合理培养周期以3至5年103份（63.6%）为主。建议将短期实训嵌入多阶段发展安排，而非把一次培训认定为复合能力形成。Q24和Q40对分层与全链条路径的完整认可分布见附录，尚不能证明任一阶段安排具有因果效果。

六 组织保障与成果转化

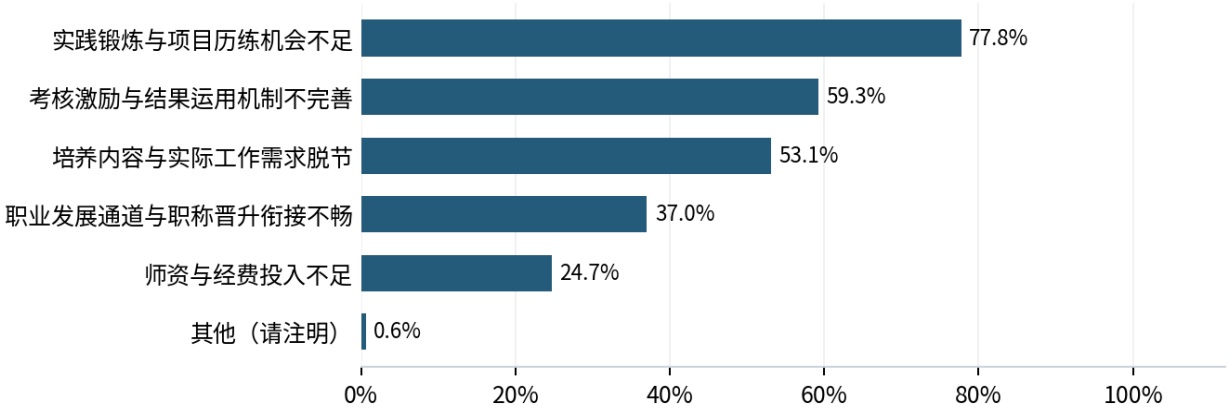
现有培训的主要问题



来源 Q19；最多4项；分母162

短期集中为主、缺乏跟踪管理108份（66.7%），分层分类不够、针对性不强82份（50.6%）。这提示改善重点不仅是增加课程，还包括明确学习前目标、过程辅导、培训后项目成果与持续追踪。

成果转化落地的主要障碍



来源 Q46；最多3项；分母162

实践锻炼与项目历练机会不足126份（77.8%），考核激励与结果运用机制不完善96份（59.3%）。实践基地、真实项目池与评价机制应同步设计，避免只有培训而没有可执行任务，也避免把培训完成率当作管理改善成效。

主管部门政策支持	首选人数	前三人数	前三率
纳入卫生健康人才发展规划	72	120	74.1%
设立专项培养经费	33	106	65.4%
高端人才计划倾斜	17	68	42.0%
薪酬激励政策	13	60	37.0%

主管部门政策支持	首选人数	前三人数	前三率
岗位设置与编制保障	11	47	29.0%
学时学分认定与职称衔接	7	43	26.5%
实训基地与师资库建设	9	42	25.9%

Q28有3份同时选择尚无合作与具体合作形式，标为潜在矛盾但主分析保留；Q30有7份同时选择尚无系统评估与某具体评价方式，可能存在零散评价但尚未形成体系，不能改写为完全没有任何评价。

政策前三需求以纳入卫生健康人才发展规划120份（74.1%）和设立专项培养经费106份（65.4%）较突出。结合Q32至Q35对组织机制、激励与职业通道的评分，建议政策试点把职责、经费、实践任务及职业发展衔接成完整流程，并记录实际执行程度。

七 探索性比较与不确定性

制度落实与评估的关联

制度落实到位者32份中，选择“ 尚无系统评估 ”的有9份（28.1%）；其他回答130份中有76份（58.5%）。两组比例差为-30.3个百分点，未作多重性调整的Newcombe 95%区间为-45.3至-11.1个百分点；双侧Fisher p=0.002773，制度落实3项家族BH q=0.008318。

这一结果说明制度落实与评估安排同时出现，但横截面问卷无法判断时间先后、共同治理能力或机构资源的作用。其他130份由49份“ 有制度但落实不足 ”和81份“ 无系统制度安排 ”组成；不得把组间差异写成制度的净因果效果。

结局	落实组	其他回答	比例差	p	BH q
无系统评估	9/32	76/130	-30.3个百分点	0.0028	0.0083
缺乏培训后跟踪	20/32	88/130	-5.2个百分点	0.6760	0.6760
激励结果运用障碍	22/32	74/130	11.8个百分点	0.2369	0.3554

医院类别与职务的探索性分组

医院类别比较限定原题三级类别145份与二级类别14份，其他3份不进入该比较。本次列明的12个探索性结局中，最低BH q=0.5621。小组样本不足、统计功效有限，不足以据此制定已经验证的医院层级最优方案。职务比较为Q4编码1至4共91份与其他71份；其他类别含多种岗位经历，不能称为统一的非管理专业群体。

本次分组表是探索性比较，不构成回归调整后的效应。医院类别、地区、职务、专业与机构资源可能同时影响回答。应在下一轮采样时明确医院标识和抽样框，预先选定少量关键终点，按医院聚类评估。完整33项比较见附录与工作簿。

八 人员结构选答的专门核验

Q11的原题范围是总会计师、财务（不含窗口收费人员）、审计、运营、合规、医保、绩效等部门人员。不能默认填报值代表全院职工，也不能认定所有受访者对经济管理范围有相同理解。Q11总人数字段有效98份、合计12573、最大5300；如此大的单条计数需要回访核实，但大值本身不证明错误，本次主样本不予删除。

题目	任一非空	任一有效数值	全部字段有效	整题空白
Q11 15字段	102	100	78	60
Q12 6字段	100	98	81	62

原始空白包含字符串“(空)”，另有“不清楚”“不知道”等非数值。有效数字定义为非负整数；零是有效填报，不按空白处理。总人数有效98份与其余64份的可用性比较，分组口径不同于“任一作答102与空白60”，不得混称。

总人数字段情景	记录数	计数合计
仅去除最大0条总人数记录的情景	98	12,573
仅去除最大1条总人数记录的情景	97	7,273
仅去除最大2条总人数记录的情景	96	5,926
仅去除最大3条总人数记录的情景	95	4,915

以上均为未按医院去重的记录计数之和，不是真实独立人员数。最大记录移除后合计变化显著，表明用一个汇总总量描述行业人员规模不稳妥。

类别加总只用于假设性敏感性

学历、职称、专业分项是否互斥且穷尽未获证实。分项和等于总人数是一种核对条件，不能被当作无误填写的认证。不同结构的可用记录不同，不能把各列全部有效值合计拼成同一总体画像。

结构与情景	记录数	项目计数/同记录总数	计数比
学历 本科 分项和等于总人数	73	5317/9166	58.0%
学历 本科 相等且总人数不超IQR上界	69	1498/2129	70.4%
专业 财会审计类 分项和等于总人数	65	1405/3619	38.8%
专业 财会审计类 相等且总人数不超IQR上界	62	1332/1882	70.8%

IQR高值上界由Q11总人数有效记录计算，为102；超过该阈值仅作为敏感性排除条件，不认定为错误。教育和专业占比对大额记录的敏感程度不同，专业计数比从38.8%到70.8%的变化尤其提示口径风险。

Q12的资格计数不可相加为持证人数

Q12明确要求同一人持有多项资格分别计入。CPA字段有效87份、计数和91；CMA字段有效82份、计数和32。各字段来自不同可用记录，资格可能重叠，不能把两者或全部资格合计解释为独立持证人数。旧建议中CPA45和管理会计14未在相同口径下重现，应以原始题目和明确分母重做，而不是强制对齐旧数。

九 稳健性与旧结论检查

少于300秒的答卷2份，59个量表子项全部同分的答卷5份，合并标记6份。此类特征仅提示需要复核，不是无效认定。主分析保留全部162份，敏感性分析排除这6份后使用156份。

情景	数智高需求	跟岗前三	缺乏跟踪	数据高差距
全样本	156/162（96.3%）	125/162（77.2%）	108/162（66.7%）	57/162（35.2%）
剔除快速或全量表同分	150/156（96.2%）	120/156（76.9%）	104/156（66.7%）	51/156（32.7%）
去除江苏与河南	87/91（95.6%）	70/91（76.9%）	58/91（63.7%）	25/91（27.5%）

去除江苏与河南后为91份，数据高差距25/91（27.5%），低于全样本35.2%。因此只能说若干核心需求方向在快速或同分标记敏感性中相近，不能笼统宣称全部结论对地区构成都稳健。地区排除同时改变样本结构，也不能解释为地区本身的因果影响。

待核验说法	本次证据	结论
本科主导、中级及以下超过85%	个人硕士54.3%；高级46.3%	不适用于受访者个人结构
管理者或领导人数混用	管理者91；院领导及总会计师20	必须明确Q4定义
业务差距显著高于数据差距	精确p=.05049；10对BH q=.07214	差异不确定
未来需求前三为运营、数据、成本	综合89高于成本83	第三位应为综合
医保排名低说明不重要	人才前三25.9%；课程高必要92.0%	两题不可作该推论
1140、1144、1145为可靠总人数	Q11有效98、计数12573，未医院去重	旧总数未重现且口径不明
CPA45、管理会计14	CPA计数91；CMA计数32	相应口径未重现
按医院层级已证明最优策略不同	二级仅14份，探索性比较有限	证据不足

开放意见的编码解释

Q47有12份实质意见。本次采用公开可复现关键词规则并人工检查，多标签主题为治理与组织支持7、职业发展与公平激励3、实践应用3、经费或学习实践机会2、协同与案例共享1。此前汇总的治理制度为6，本版将领导认可等组织支持纳入更宽的治理与组织支持主题，不能把主题计数变化当作受访者新增意见。主题分母为12，原文及序号不公开。

旧汇总中的业务与数据p约0.0502来自随机模拟。本版使用精确符号翻转p=0.0504946，并对完整10对维度进行BH校正，因此q与此前较小的三对比较家族不完全相同。方法变化不改变“业务与数据之间尚不明确”的判断。

十 可执行建议与后续研究

第一阶段 核实需求与确定试点

由医院培养归口部门会同财务、运营、医保、临床与信息部门，在现有培训目录基础上核对数据工具、业务流程与真实管理项目供给。以问卷显示的数智、业务和运营需求为线索，选取2至3个能获得数据和业务配合的项目，例如病种成本与运营分析、预算执行偏差分析或医保精细化管理。具体项目数量为实施建议，不是调查测量结果。

第二阶段 设计分层实践任务

新入职人员以流程理解、制度规范和数据基础为主；业务骨干承担分析与改进任务；中层侧重跨部门协同、项目治理与带教；领军人才侧重战略和系统治理。该分层来自原题及管理设计逻辑，需根据岗位实测能力调整，不应仅凭职称或年龄分配学习机会。采用跟岗、真实项目、案例复盘与双导师支持的组合，明确每项任务的业务问题、交付物和评价人。

第三阶段 跟踪评估与结果运用

环节	建议记录的可观察指标	解释要求
学习前	岗位任务清单、基线能力测评、项目基线	不把自评需求当作客观能力
学习中	导师反馈、参与时间、阶段成果	跟踪过程，避免只记出勤
学习后	案例与分析报告质量、应用情况	培训完成不等于成果落地
后续追踪	同口径业务指标、使用部门反馈、持续应用	注明同时期改革和资源变化
激励运用	公开评价标准、岗位与成长机会衔接	避免仅以证书或短期分数定优劣

建议先进行小规模分阶段试点，再评价是否扩展。若资源允许，可采用分批上线的比较设计，预先确定主要终点、追踪时间、缺失处理和分析计划。避免事后挑选显著结果作为有效性证明。

下一轮调查的必要改进

建立非公开、可去重的医院标识；补充抽样框、邀请范围和响应率；扩大二级与基层覆盖；对Q11明确总人数范围、分项是否互斥及类别加总规则；对Q12区分资格人次与独立人数；在Q41与Q42之间加入跳题或“ 从未开展 ”选项；采集现有课程名称、实际培训投入和项目成果，以缩小当前“ 主观偏好 ”与“ 实际效果 ”之间的证据距离。

附录A 47题完整统计

本附录按原题顺序列出全部题目。除Q11、Q12和Q47专门分母外，表中人数均为答卷数。量表分布依次为1至5分人数，高分为4至5分；Q22与Q35含义不同，必须连同题目锚点阅读。多选和排序选项保留原始术语，其他项的自由填写内容不公开。

Q1 (1)1.贵院所在省份:___

选项	人数	分母	比例
江苏	38	162	23.5%
河南	33	162	20.4%
上海	20	162	12.3%
广西	17	162	10.5%
浙江	14	162	8.6%
北京	8	162	4.9%
湖北	5	162	3.1%
吉林	5	162	3.1%
湖南	4	162	2.5%
四川	4	162	2.5%
广东	4	162	2.5%
山东	3	162	1.9%
天津	2	162	1.2%
陕西	2	162	1.2%
云南	2	162	1.2%
河北	1	162	0.6%

仅按省份汇总，统一去除省、市后缀（如江苏省与江苏合并）；不发布城市或省份与个人特征交叉组合，不能据省份数量推断地区代表性。

数据追溯 数值版 Sheet1!G2:H163

Q2 2.贵院类别（单选）

选项	人数	分母	比例
三级综合医院	106	162	65.4%
三级专科医院	39	162	24.1%
二级综合医院	13	162	8.0%
二级专科医院	1	162	0.6%
其他（请注明）	3	162	1.9%

按原题编码和文本标签统计；其他选项中的填写内容不公开。仅展示本样本实际出现的编码。

数据追溯 数值版 Sheet1!I2:I163

Q3 3.您所在部门（单选）

选项	人数	分母	比例
领导班子成员	19	162	11.7%
财务部门	92	162	56.8%
审计部门	17	162	10.5%
运营管理部门	22	162	13.6%
医保管理部门	1	162	0.6%
绩效/人事部门	5	162	3.1%
院办/综合管理部门	1	162	0.6%
其他	5	162	3.1%

按原题编码和文本标签统计；其他选项中的填写内容不公开。仅展示本样本实际出现的编码。

数据追溯 数值版 Sheet1!J2:J163

Q4 4.您的职务（单选）

选项	人数	分母	比例
院级领导	6	162	3.7%
总会计师	14	162	8.6%
部门正职	41	162	25.3%
部门副职	30	162	18.5%
其他	71	162	43.8%

按原题编码和文本标签统计；其他选项中的填写内容不公开。仅展示本样本实际出现的编码。

数据追溯 数值版 Sheet1!K2:K163

Q5 5.您的年龄（单选）

选项	人数	分母	比例
51岁及以上	18	162	11.1%
41—50岁	43	162	26.5%
31—40岁	99	162	61.1%
30岁及以下	2	162	1.2%

按原题编码和文本标签统计；其他选项中的填写内容不公开。仅展示本样本实际出现的编码。

数据追溯 数值版 Sheet1!L2:L163

Q6 6.您的最高学历（单选）

选项	人数	分母	比例
博士	3	162	1.9%
硕士	88	162	54.3%
本科	70	162	43.2%
大专及以下	1	162	0.6%

按原题编码和文本标签统计；其他选项中的填写内容不公开。仅展示本样本实际出现的编码。

数据追溯 数值版 Sheet1!M2:M163

Q7 7.您的专业背景（单选）

选项	人数	分母	比例
财会审计类	142	162	87.7%
医疗/护理类	1	162	0.6%
卫生管理类	5	162	3.1%
经济金融类	9	162	5.6%
信息技术类	3	162	1.9%
其他	2	162	1.2%

按原题编码和文本标签统计；其他选项中的填写内容不公开。仅展示本样本实际出现的编码。

数据追溯 数值版 Sheet1!N2:N163

Q8 8.您的职称（单选）

选项	人数	分母	比例
正高级	25	162	15.4%
副高级	50	162	30.9%
中级	83	162	51.2%
初级及以下	1	162	0.6%
未评聘	3	162	1.9%

按原题编码和文本标签统计；其他选项中的填写内容不公开。仅展示本样本实际出现的编码。

数据追溯 数值版 Sheet1!O2:O163

Q9 9.您从事卫生健康经济管理相关工作的年限（单选）

选项	人数	分母	比例
20年以上	40	162	24.7%
11—20年	67	162	41.4%
6—10年	45	162	27.8%
3—5年	7	162	4.3%
3年以下	3	162	1.9%

按原题编码和文本标签统计；其他选项中的填写内容不公开。仅展示本样本实际出现的编码。

数据追溯 数值版 Sheet1!P2:P163

Q10 10.贵院岗位与机构设置情况（分别勾选）—设置总会计师岗位

项目	是	否	分母	是比例
设置总会计师岗位	109	53	162	67.3%
设立独立运营管理部门	102	60	162	63.0%
设置独立医保管理部门	151	11	162	93.2%
设置独立内部审计部门	150	12	162	92.6%
明确经济管理人员培养归口管理部门	76	86	162	46.9%

数值编码1=是、2=否，已与文本版交叉核对。

数据追溯 数值版 Sheet1!Q2:U163

Q11 (1)11.贵院经济管理人员队伍结构（填写人数，本部分所称经济管理人员，是指总会计师、财务（不含窗口收费人员）、审计、运营、合规、医保、绩效等部门人员，下同。） 在岗总人数___

项目	有效数	空白	非空无效	计数和	中位数	最大值
在岗总人数	98	62	2	12573	27.0	5300
其中:博士	92	67	3	523	0.0	500
硕士	90	70	2	1909	4.5	1300
本科	91	69	2	5992	18.0	2500
大专及以下	88	72	2	1672	2.0	1000
职称:正高级	90	70	2	479	1.0	300
副高级	91	69	2	1544	3.0	800
中级	88	72	2	3086	10.0	1500
初级及以下	89	71	2	4117	9.0	2700
专业背景:财会审计类	91	69	2	1985	17.0	100
医疗/护理类	85	75	2	5495	1.0	4100
卫生管理类	84	76	2	602	0.0	300
信息技术类	84	76	2	294	0.0	200
经济金融类	84	76	2	193	0.0	50
其他	82	78	2	944	0.0	500

每列使用各自有效非负整数记录；空白与非数值分别报告。计数合计未经医院去重，不能视为独立人员总量。Q12明确允许同人多证。

数据追溯 数值版 Sheet1!V2:AJ163

Q12 (1)12.贵院经济管理人员中持有会计、审计、经济专业技术资格或CPA/CMA/CIA等职业资格的人员情况（同一人持有多项资格的分别计入） 正高级专业技术资格___

项目	有效数	空白	非空无效	计数和	中位数	最大值
正高级专业技术资格	92	68	2	99	1.0	5
副高级专业技术资格	93	66	3	329	2.0	21
中级专业技术资格	89	71	2	799	6.0	36
初级及以下专业技术资格	89	71	2	971	7.0	44
注册会计师（CPA）	87	73	2	91	1.0	5
管理会计师（CMA）	82	78	2	32	0.0	13

每列使用各自有效非负整数记录；空白与非数值分别报告。计数合计未经医院去重，不能视为独立人员总量。Q12明确允许同人多证。

数据追溯 数值版 Sheet1!AK2:AP163

Q13 13.贵院经济管理人员配置的充足程度（单选）

选项	人数	分母	比例
严重不足	10	162	6.2%
相对不足	72	162	44.4%
基本满足	68	162	42.0%
比较充足	12	162	7.4%

按原题编码和文本标签统计；其他选项中的填写内容不公开。仅展示本样本实际出现的编码。

数据追溯 数值版 Sheet1!AQ2:AQ163

Q14 14.当前最紧缺的岗位（可多选，最多3项）

选项	选择人数	分母	选择率
成本核算	68	162	42.0%
预算管理	36	162	22.2%
运营分析	93	162	57.4%
医保管理	21	162	13.0%
内部审计	17	162	10.5%
物价管理	11	162	6.8%
绩效管理	21	162	13.0%
数据分析/信息化	103	162	63.6%
综合财务管理	63	162	38.9%

分母为全部162份答卷；多选比例之和可超过100%。未勾选不能等同独立核实没有。

数据追溯 数值版 Sheet1!AR2:AZ163

Q15 15.贵院是否建立了经济管理人员培养培训制度并落实到位（单选）

选项	人数	分母	比例
有制度且落实到位	32	162	19.8%
有制度但落实不足	49	162	30.2%
无系统制度安排	81	162	50.0%

按原题编码和文本标签统计；其他选项中的填写内容不公开。仅展示本样本实际出现的编码。

数据追溯 数值版 Sheet1!BA2:BA163

Q16 16.贵院经济管理人员年人均培训学时（单选）

选项	人数	分母	比例
20学时以下	50	162	30.9%
20—40学时	53	162	32.7%
41—60学时	21	162	13.0%
61—90学时	20	162	12.3%
90学时以上	18	162	11.1%

按原题编码和文本标签统计；其他选项中的填写内容不公开。仅展示本样本实际出现的编码。

数据追溯 数值版 Sheet1!BB2:BB163

Q17 17.贵院现有培养培训的内容（可多选）

选项	选择人数	分母	选择率
会计准则与制度	112	162	69.1%
预算绩效管理	100	162	61.7%
DRG/DIP与医保政策	97	162	59.9%
成本核算	83	162	51.2%
信息化与数据工具	49	162	30.2%
管理沟通与领导力	30	162	18.5%
政策法规与合规	85	162	52.5%
其他	5	162	3.1%

分母为全部162份答卷；多选比例之和可超过100%。未勾选不能等同独立核实没有。

数据追溯 数值版 Sheet1!BC2:BJ163

Q18 18.贵院现有培养培训的方式（可多选）

选项	选择人数	分母	选择率
院内讲座	90	162	55.6%
外派短期集中培训	122	162	75.3%
学历学位教育	55	162	34.0%
跟岗学习/轮岗	70	162	43.2%
线上课程	90	162	55.6%
导师制带教	10	162	6.2%
学术会议与专题研讨	67	162	41.4%

分母为全部162份答卷；多选比例之和可超过100%。未勾选不能等同独立核实没有。

数据追溯 数值版 Sheet1!BK2:BQ163

Q19 19.当前培养培训工作存在的主要问题（可多选，最多4项）

选项	选择人数	分母	选择率
培训内容脱离医院实务	46	162	28.4%
短期集中为主、缺乏跟踪管理	108	162	66.7%
缺乏效果评估机制	70	162	43.2%
分层分类不够、针对性不强	82	162	50.6%
师资力量不足	18	162	11.1%
工作学习矛盾突出、时间难保障	70	162	43.2%
缺乏考核激励、学用脱节	53	162	32.7%
经费投入不足	36	162	22.2%
其他	0	162	0.0%

分母为全部162份答卷；多选比例之和可超过100%。未勾选不能等同独立核实没有。

数据追溯 数值版 Sheet1!BR2:BZ163

Q20 20.贵院业财融合推进程度（单选）

选项	人数	分母	比例
尚未起步	7	162	4.3%
试点探索	35	162	21.6%
部分领域推进	84	162	51.9%
全面推进	31	162	19.1%
深度融合发展	5	162	3.1%

按原题编码和文本标签统计；其他选项中的填写内容不公开。仅展示本样本实际出现的编码。

数据追溯 数值版 Sheet1!CA2:CA163

Q21 21.贵院业财融合已实施的管理举措（可多选）

选项	选择人数	分母	选择率
DRG/DIP医保支付方式改革	109	162	67.3%
全面预算管理	127	162	78.4%
全成本核算	102	162	63.0%
公立医院绩效考核	121	162	74.7%
内部控制建设与财会监督	101	162	62.3%
智慧医院/运营数据中心建设	73	162	45.1%
其他	0	162	0.0%

分母为全部162份答卷；多选比例之和可超过100%。未勾选不能等同独立核实没有。

数据追溯 数值版 Sheet1!CB2:CH163

Q22 22.现有队伍与“ 懂业务、通财务、善管理、会数据、防风险 ”复合型人才要求的差距有多大?请在相应栏内打“ √ ”（1=差距很小，5=差距很大） —D1 懂业务:理解医疗业务流程与临床运行规律

子项	1至5分人数	均值±标准差	4至5分 n/N	高分比例
D1 懂业务:理解医疗业务流程与临床运行规律	8 / 20 / 68 / 47 / 19	3.30±1.00	66/162	40.7%
D2 通财务:掌握财务、预算、成本专业知识	33 / 44 / 43 / 29 / 13	2.66±1.22	42/162	25.9%
D3 善管理:具备运营管理与综合协调能力	7 / 32 / 78 / 29 / 16	3.09±0.97	45/162	27.8%
D4 会数据:具备数字化工具与数据分析能力	14 / 22 / 69 / 43 / 14	3.13±1.04	57/162	35.2%
D5 防风险:具备内控、审计与合规监督能力	10 / 39 / 64 / 36 / 13	3.02±1.02	49/162	30.2%

保留完整五级分布，均值为辅助描述。Q22高分代表差距较大；Q35高分代表通道较畅通；其余各题以原题锚点解释。不同量表不能简单合并为人才能力总分。

数据追溯 数值版 Sheet1!CI2:CM163

Q23 23.未来3年贵院最急需的经济管理人才类型（请排序前3位，1=最急需，2=次之，3=再次之）

选项	第1	第2	第3	前三人数	首选率	前三率
成本与预算管理人才	29	24	30	83	17.9%	51.2%
运营管理人才	67	43	23	133	41.4%	82.1%
医保管理人才	6	19	17	42	3.7%	25.9%
内审与监督人才	3	3	13	19	1.9%	11.7%
数据分析人才	23	57	40	120	14.2%	74.1%
综合管理人才	34	16	39	89	21.0%	54.9%

首选率与前三入选率分别报告；3、2、1加权分仅为透明描述性排序，不是问卷原有量表或已验证效用。

数据追溯 数值版 Sheet1!CN2:CS163

Q24 24.对分层分类培养模式各层级培养重点的认同程度（1=很不认同，5=很认同），请在相应栏内打“ √ ”—E1 新入职人员:夯实财务、医疗、管理、信息交叉基础，强化跟岗实训与基本制度规范

子项	1至5分人数	均值±标准差	4至5分 n/N	高分比例
E1 新入职人员:夯实财务、医疗、管理、信息交叉基础，强化跟岗实训与基本制度规范	5 / 4 / 13 / 29 / 111	4.46±0.97	140/162	86.4%
E2 业务骨干人员:围绕预算绩效、成本核算、数智运营、风控监督等专项能力系统深化	4 / 1 / 12 / 26 / 119	4.57±0.85	145/162	89.5%
E3 中层管理人员:提升运营管理、跨部门协同与团队带教能力	4 / 2 / 11 / 25 / 120	4.57±0.87	145/162	89.5%
E4 领军人才（总会计师及院领导）:提升战略思维、行业引领与穿透式监管能力	5 / 1 / 8 / 25 / 123	4.60±0.87	148/162	91.4%

保留完整五级分布，均值为辅助描述。Q22高分代表差距较大；Q35高分代表通道较畅通；其余各题以原题锚点解释。不同量表不能简单合并为人才能力总分。

数据追溯 数值版 Sheet1!CT2:CW163

Q25 25.您认为最有效的培养方式（请选出3项并排序，1=最有效，2=次之，3=再次之）

选项	第1	第2	第3	前三人数	首选率	前三率
双导师制（业务导师+财务导师）	33	8	21	62	20.4%	38.3%
跟岗实训/实训医院	65	44	16	125	40.1%	77.2%
真实案例教学与案例库	21	39	30	90	13.0%	55.6%
项目制学习（参与实际管理项目）	30	33	32	95	18.5%	58.6%
学历学位教育	1	3	6	10	0.6%	6.2%
短期专题研修	1	12	15	28	0.6%	17.3%
线上自主学习平台	2	1	1	4	1.2%	2.5%
跨部门交流挂职	9	22	41	72	5.6%	44.4%

首选率与前三入选率分别报告；3、2、1加权分仅为透明描述性排序，不是问卷原有量表或已验证效用。

数据追溯 数值版 Sheet1!CX2:DE163

Q26 26.下列课程模块对人才培养的必要程度（1=很没必要，5=很有必要），请在相应栏内打“ √ ”—F1 战略管理与领导力

子项	1至5分人数	均值±标准差	4至5分 n/N	高分比例
F1 战略管理与领导力	0 / 5 / 26 / 49 / 82	4.28±0.84	131/162	80.9%
F2 卫生政策与财经法规	0 / 2 / 13 / 41 / 106	4.55±0.70	147/162	90.7%
F3 医疗业务流程与临床认知	0 / 1 / 11 / 49 / 101	4.54±0.65	150/162	92.6%
F4 跨部门沟通与协同管理	0 / 0 / 10 / 42 / 110	4.62±0.60	152/162	93.8%
F5 DRG/DIP与医保精细化管理	0 / 1 / 12 / 44 / 105	4.56±0.66	149/162	92.0%
F6 预算管理与绩效评价	0 / 2 / 9 / 44 / 107	4.58±0.66	151/162	93.2%
F7 成本核算与运营分析	0 / 1 / 5 / 45 / 111	4.64±0.58	156/162	96.3%
F8 数智化运营与数据分析	0 / 0 / 6 / 37 / 119	4.70±0.54	156/162	96.3%
F9 内部控制、审计与风险防控	0 / 1 / 17 / 38 / 106	4.54±0.71	144/162	88.9%
F10 科教管理与成果转化	1 / 10 / 37 / 54 / 60	4.00±0.95	114/162	70.4%

保留完整五级分布，均值为辅助描述。Q22高分代表差距较大；Q35高分代表通道较畅通；其余各题以原题锚点解释。不同量表不能简单合并为人才能力总分。

数据追溯 数值版 Sheet1!DF2:DO163

Q27 27.下列培养方式对人才培养的支持作用（1=作用很小，5=作用很大），请在相应栏内打“ √ ”—G1 案例库与教学案例开发

子项	1至5分人数	均值±标准差	4至5分 n/N	高分比例
G1 案例库与教学案例开发	1 / 3 / 18 / 53 / 87	4.37±0.80	140/162	86.4%
G2 实训基地（实训医院）	0 / 1 / 14 / 47 / 100	4.52±0.68	147/162	90.7%
G3 线上学习平台与移动微课堂	3 / 13 / 44 / 55 / 47	3.80±1.01	102/162	63.0%
G4 真实管理项目池（项目制学习）	0 / 2 / 12 / 51 / 97	4.50±0.69	148/162	91.4%
G5 虚拟运营沙盘演练	5 / 7 / 41 / 56 / 53	3.90±1.01	109/162	67.3%

保留完整五级分布，均值为辅助描述。Q22高分代表差距较大；Q35高分代表通道较畅通；其余各题以原题锚点解释。不同量表不能简单合并为人才能力总分。

数据追溯 数值版 Sheet1!DP2:DT163

Q28 28.贵院与院校、专业机构的合作形式（可多选）

选项	选择人数	分母	选择率
共建课程体系	44	162	27.2%
共建案例库	35	162	21.6%
共建实践基地	49	162	30.2%
联合开展岗位能力评价	17	162	10.5%
互派师资/导师	13	162	8.0%
委托开展专项培训	49	162	30.2%
尚无合作	80	162	49.4%

分母为全部162份答卷；多选比例之和可超过100%。未勾选不能等同独立核实没有。

数据追溯 数值版 Sheet1!DU2:EA163

Q29 29.贵院与院校、专业机构的“ 业务导师+财务导师 ”双导师制（单选）

选项	人数	分母	比例
已实施	7	162	4.3%
有意愿、一年内启动	12	162	7.4%
有意愿但条件暂不具备	91	162	56.2%
暂无意愿	52	162	32.1%

按原题编码和文本标签统计；其他选项中的填写内容不公开。仅展示本样本实际出现的编码。

数据追溯 数值版 Sheet1!EB2:EB163

Q30 30.贵院对培养效果的评估与结果运用方式（可多选）

选项	选择人数	分母	选择率
阶段性测试或结业考核	43	162	26.5%
培训前后绩效指标对照	37	162	22.8%
成果汇报与案例产出	70	162	43.2%
培训结果与考核、聘任挂钩	22	162	13.6%
尚无系统评估	85	162	52.5%

分母为全部162份答卷；多选比例之和可超过100%。未勾选不能等同独立核实没有。

数据追溯 数值版 Sheet1!EC2:EG163

Q31 31.您认为经济管理骨干成长为复合型人才所需的合理培养周期（单选）

选项	人数	分母	比例
3年以下	23	162	14.2%
3—5年	103	162	63.6%
6—10年	28	162	17.3%
10年及以上	8	162	4.9%

按原题编码和文本标签统计；其他选项中的填写内容不公开。仅展示本样本实际出现的编码。

数据追溯 数值版 Sheet1!EH2:EH163

Q32 32.下列院内长效保障机制对人才培养落地的重要程度（1=很不重要，5=很重要），请在相应栏内打“ √ ”—H1 组织领导与归口管理

子项	1至5分人数	均值±标准差	4至5分 n/N	高分比例
H1 组织领导与归口管理	0 / 2 / 11 / 39 / 110	4.59±0.67	149/162	92.0%
H2 岗位设置与总会计师制度落实	1 / 1 / 17 / 47 / 96	4.46±0.76	143/162	88.3%
H3 师资队伍建设（双师型、行业导师库）	0 / 5 / 20 / 60 / 77	4.29±0.80	137/162	84.6%
H4 经费投入保障	0 / 3 / 8 / 47 / 104	4.56±0.68	151/162	93.2%
H5 考核激励与培训结果运用	0 / 2 / 8 / 44 / 108	4.59±0.65	152/162	93.8%
H6 职业发展通道与职称晋升衔接	0 / 2 / 5 / 41 / 114	4.65±0.61	155/162	95.7%
H7 学习时间保障与安排	0 / 2 / 13 / 46 / 101	4.52±0.70	147/162	90.7%
H8 信息化学习平台与培训档案管理	0 / 2 / 26 / 61 / 73	4.27±0.77	134/162	82.7%

保留完整五级分布，均值为辅助描述。Q22高分代表差距较大；Q35高分代表通道较畅通；其余各题以原题锚点解释。不同量表不能简单合并为人才能力总分。

数据追溯 数值版 Sheet1!EI2:EP163

Q33 33.对下列人才培养体系机制建设的认同程度（1=很不支持，5=很支持），请在相应栏内打“ √ ”—I1 建立分层分类培训体系

子项	1至5分人数	均值±标准差	4至5分 n/N	高分比例
I1 建立分层分类培训体系	0 / 1 / 8 / 45 / 108	4.60±0.61	153/162	94.4%
I2 建立岗位胜任力评价体系	0 / 1 / 12 / 45 / 104	4.56±0.66	149/162	92.0%
I3 建立行业经济管理人才库	0 / 1 / 16 / 43 / 102	4.52±0.70	145/162	89.5%
I4 建立行业师资库与课程认证制度	0 / 1 / 18 / 49 / 94	4.46±0.71	143/162	88.3%
I5 继续教育学分与职称评审衔接制度	1 / 3 / 16 / 48 / 94	4.43±0.79	142/162	87.7%

保留完整五级分布，均值为辅助描述。Q22高分代表差距较大；Q35高分代表通道较畅通；其余各题以原题锚点解释。不同量表不能简单合并为人才能力总分。

数据追溯 数值版 Sheet1!EQ2:EU163

Q34 34.培养结果与考核激励挂钩方式的选择（单选;下列挂钩方式的必要程度1=很没必要，5=很有必要），请在相应栏内打"√"—J1 评优评先

子项	1至5分人数	均值±标准差	4至5分 n/N	高分比例
J1 评优评先	2 / 4 / 18 / 38 / 100	4.42±0.88	138/162	85.2%
J2 岗位聘任	1 / 4 / 7 / 37 / 113	4.59±0.74	150/162	92.6%
J3 薪酬激励	1 / 5 / 6 / 38 / 112	4.57±0.76	150/162	92.6%
J4 职称推荐	1 / 3 / 5 / 39 / 114	4.62±0.70	153/162	94.4%
J5 人才计划推荐	1 / 2 / 9 / 37 / 113	4.60±0.71	150/162	92.6%

保留完整五级分布，均值为辅助描述。Q22高分代表差距较大；Q35高分代表通道较畅通；其余各题以原题锚点解释。不同量表不能简单合并为人才能力总分。

数据追溯 数值版 Sheet1!EV2:EZ163

Q35 35.贵院经济管理人员职业发展通道各环节的畅通程度（1=严重梗阻，5=非常畅通），请在相应栏内打"√"—K1 职称评审与聘任通道

子项	1至5分人数	均值±标准差	4至5分 n/N	高分比例
K1 职称评审与聘任通道	9 / 14 / 41 / 48 / 50	3.72±1.16	98/162	60.5%
K2 岗位层级与职务晋升通道	8 / 15 / 50 / 46 / 43	3.62±1.12	89/162	54.9%
K3 跨部门轮岗与交流通道	8 / 23 / 56 / 36 / 39	3.46±1.15	75/162	46.3%
K4 专业能力进阶与培训通道	5 / 8 / 53 / 47 / 49	3.78±1.03	96/162	59.3%
K5 领军人才与后备人才成长通道	7 / 10 / 52 / 46 / 47	3.72±1.08	93/162	57.4%
K6 薪酬待遇与个人价值体现	5 / 17 / 49 / 52 / 39	3.64±1.06	91/162	56.2%

保留完整五级分布，均值为辅助描述。Q22高分代表差距较大；Q35高分代表通道较畅通；其余各题以原题锚点解释。不同量表不能简单合并为人才能力总分。

数据追溯 数值版 Sheet1!FA2:FF163

Q36 36.贵院经济管理人员年人均培训经费（单选）

选项	人数	分母	比例
1000元以下	48	162	29.6%
1000—3000元	62	162	38.3%
3000—5000元	31	162	19.1%
5000—10000元	14	162	8.6%
10000元以上	7	162	4.3%

按原题编码和文本标签统计；其他选项中的填写内容不公开。仅展示本样本实际出现的编码。

数据追溯 数值版 Sheet1!FG2:FG163

Q37 37.贵院经济管理人员培养经费来源（可多选）

选项	选择人数	分母	选择率
单位预算安排	148	162	91.4%
主管部门专项经费	62	162	38.3%
学会/协会项目支持	30	162	18.5%
个人承担	33	162	20.4%
其他	2	162	1.2%

分母为全部162份答卷；多选比例之和可超过100%。未勾选不能等同独立核实没有。

数据追溯 数值版 Sheet1!FH2:FL163

Q38 38.您最希望主管部门出台的政策支持（请排序前3位，1=最迫切，2=次之，3=再次之）

选项	第1	第2	第3	前三人数	首选率	前三率
纳入卫生健康人才发展规划	72	27	21	120	44.4%	74.1%
设立专项培养经费	33	46	27	106	20.4%	65.4%
学时学分认定与职称衔接	7	14	22	43	4.3%	26.5%
高端人才计划倾斜	17	23	28	68	10.5%	42.0%
实训基地与师资库建设	9	16	17	42	5.6%	25.9%
岗位设置与编制保障	11	16	20	47	6.8%	29.0%
薪酬激励政策	13	20	27	60	8.0%	37.0%

首选率与前三入选率分别报告；3、2、1加权分仅为透明描述性排序，不是问卷原有量表或已验证效用。

数据追溯 数值版 Sheet1!FM2:FS163

Q39 39.贵院人才培养组织管理情况（分别勾选）—成立人才培养领导小组

项目	是	否	分母	是比例
成立人才培养领导小组	47	115	162	29.0%
明确人才培养归口管理部门	91	71	162	56.2%
制定中长期人才培养规划	69	93	162	42.6%
建立培养档案与学时台账	51	111	162	31.5%

数值编码1=是、2=否，已与文本版交叉核对。

数据追溯 数值版 Sheet1!FT2:FW163

Q40 40.对“ 在校培养—岗位适应—能力提升—领军人才 ”四阶段全链条培养路径各环节重点的认同程度（1=很不认同，5=很认同），请在相应栏内打“ √ ”—L1 在校培养阶段:夯实财务、医疗、管理、信息交叉基础知识

子项	1至5分人数	均值±标准差	4至5分 n/N	高分比例
L1 在校培养阶段:夯实财务、医疗、管理、信息交叉基础知识	1 / 1 / 11 / 42 / 107	4.56±0.70	149/162	92.0%
L2 岗位适应阶段:通过跟岗实训、轮岗实现实务能力转化	1 / 1 / 9 / 36 / 115	4.62±0.68	151/162	93.2%
L3 能力提升阶段:围绕预算绩效、数智运营、合规风控等专项系统深化进修	1 / 1 / 9 / 29 / 122	4.67±0.67	151/162	93.2%
L4 领军人才阶段:提升战略思维与行业引领、穿透式监管能力	1 / 0 / 10 / 32 / 119	4.65±0.65	151/162	93.2%

保留完整五级分布，均值为辅助描述。Q22高分代表差距较大；Q35高分代表通道较畅通；其余各题以原题锚点解释。不同量表不能简单合并为人才能力总分。

数据追溯 数值版 Sheet1!FX2:GA163

Q41 41.贵院经济管理人员跨部门轮岗开展情况（单选）

选项	人数	分母	比例
常态化开展	38	162	23.5%
偶尔开展	80	162	49.4%
从未开展	44	162	27.2%

按原题编码和文本标签统计；其他选项中的填写内容不公开。仅展示本样本实际出现的编码。

数据追溯 数值版 Sheet1!GB2:GB163

Q42 42.贵院经济管理人员跨部门轮岗频次（单选）

选项	人数	分母	比例
每年一轮	6	162	3.7%
每三年一轮	30	162	18.5%
每五年一轮	36	162	22.2%
其他	90	162	55.6%

按原题编码和文本标签统计；其他选项中的填写内容不公开。仅展示本样本实际出现的编码。

数据追溯 数值版 Sheet1!GC2:GC163

Q43 43.下列实战项目历练对能力提升的重要程度（1=很不重要，5=很重要），请在相应栏内打“ √ ”—M1 参与年度预算编制与执行分析

子项	1至5分人数	均值±标准差	4至5分 n/N	高分比例
M1 参与年度预算编制与执行分析	0 / 4 / 8 / 39 / 111	4.59±0.70	150/162	92.6%
M2 参与成本核算与病种盈亏分析项目	0 / 1 / 12 / 29 / 120	4.65±0.64	149/162	92.0%
M3 参与内部控制建设与内部控制评价	0 / 2 / 14 / 47 / 99	4.50±0.71	146/162	90.1%
M4 参与运营分析、报告撰写与决策支持	0 / 0 / 11 / 30 / 121	4.68±0.60	151/162	93.2%
M5 参与审计监督与财会监督	0 / 3 / 16 / 48 / 95	4.45±0.75	143/162	88.3%
M6 参与绩效分配方案设计与更正	0 / 2 / 16 / 46 / 98	4.48±0.72	144/162	88.9%
M7 参与医保收费、物价检查	0 / 1 / 19 / 46 / 96	4.46±0.72	142/162	87.7%

保留完整五级分布，均值为辅助描述。Q22高分代表差距较大；Q35高分代表通道较畅通；其余各题以原题锚点解释。不同量表不能简单合并为人才能力总分。

数据追溯 数值版 Sheet1!GD2:GJ163

Q44 44.您认为可行的实践基地建设路径（可多选）

选项	选择人数	分母	选择率
院内设立实训岗位与教学点	119	162	73.5%
依托区域龙头医院建立实训基地联盟	129	162	79.6%
依托第三方共建实践基地	88	162	54.3%
其他（请注明）	1	162	0.6%

分母为全部162份答卷；多选比例之和可超过100%。未勾选不能等同独立核实没有。

数据追溯 数值版 Sheet1!GK2:GN163

Q45 45.贵院培养成果转化途径（可多选）

选项	选择人数	分母	选择率
改进工作:将培养成果转化为实际管理改进举措	139	162	85.8%
案例总结:提炼形成典型案例并交流推广	126	162	77.8%
决策参考:形成分析建议，为领导决策提供参考	131	162	80.9%
其他（请注明）	0	162	0.0%

分母为全部162份答卷；多选比例之和可超过100%。未勾选不能等同独立核实没有。

数据追溯 数值版 Sheet1!GO2:GR163

Q46 46.您认为培养成果难以转化落地的主要障碍是（可多选，最多3项）

选项	选择人数	分母	选择率
培养内容与实际工作需求脱节	86	162	53.1%
实践锻炼与项目历练机会不足	126	162	77.8%
考核激励与结果运用机制不完善	96	162	59.3%
职业发展通道与职称晋升衔接不畅	60	162	37.0%
师资与经费投入不足	40	162	24.7%
其他（请注明）	1	162	0.6%

分母为全部162份答卷；多选比例之和可超过100%。未勾选不能等同独立核实没有。

数据追溯 数值版 Sheet1!GS2:GX163

Q47 47.您对业财融合视角下卫生健康经济管理人才培养模式、机制建设与实践路径的意见建议:

主题	涉及意见数	实质意见分母	意见内比例
治理与组织支持	7	12	58.3%
职业发展与公平激励	3	12	25.0%
实践应用	3	12	25.0%
经费或学习实践机会	2	12	16.7%
协同与案例共享	1	12	8.3%

实质意见12份，其他150份；关键词辅助、逐条人工复核的多标签探索性编码，主题可重叠，不公开原文或答卷标识；比例不能外推至全样本。

数据追溯 文本版 Sheet1!DY2:DY163；数值版GY2:GY163仅用于有无意见计数

附录B 完整比较与追溯说明

Q22全部配对比较

维度对	均值差	95%区间	精确p	10对BH q
D1 懂业务 / D2 通财务	0.642	0.442 至 0.842	2.1e-09	2.1e-08
D1 懂业务 / D3 善管理	0.210	0.064 至 0.356	0.0064	0.0106
D1 懂业务 / D4 会数据	0.173	0.006 至 0.340	0.0505	0.0721
D1 懂业务 / D5 防风险	0.284	0.104 至 0.464	0.0026	0.0052
D2 通财务 / D3 善管理	-0.432	-0.580 至 -0.284	3.01e-08	1.5e-07
D2 通财务 / D4 会数据	-0.469	-0.656 至 -0.283	2e-06	6.67e-06
D2 通财务 / D5 防风险	-0.358	-0.507 至 -0.209	4.29e-06	1.07e-05
D3 善管理 / D4 会数据	-0.037	-0.165 至 0.091	0.6368	0.6368
D3 善管理 / D5 防风险	0.074	-0.049 至 0.197	0.2790	0.3100
D4 会数据 / D5 防风险	0.111	-0.040 至 0.262	0.1715	0.2143

差值方向为表内第一维度减第二维度；区间未作多重比较调整。区间与精确检验采用不同方法，在临界值附近可能产生轻微边界差异，应以完整方法与效应大小解释。

医院类别12项

比较方向 三级类别 减 二级类别

结局	组1 n/N	组0 n/N	差值百分点	p	BH q
业务能力高差距	58/145	8/14	-17.1	0.2607	0.7821
财务能力高差距	35/145	6/14	-18.7	0.1961	0.7821
管理能力高差距	40/145	4/14	-1.0	1.0000	1.0000
数据能力高差距	49/145	6/14	-9.1	0.5605	1.0000
风险能力高差距	44/145	4/14	1.8	1.0000	1.0000
数智课程高需求	139/145	14/14	-4.1	1.0000	1.0000
跟岗进入前三	111/145	11/14	-2.0	1.0000	1.0000
无系统评估	73/145	10/14	-21.1	0.1660	0.7821
制度落实到位	30/145	2/14	6.4	0.7373	1.0000
常态化轮岗	35/145	3/14	2.7	1.0000	1.0000
人员配置不足	69/145	11/14	-31.0	0.0468	0.5621
培训经费前两档	98/145	9/14	3.3	0.7735	1.0000

职务分组12项

比较方向 Q4编码1至4 减 Q4其他

结局	组1 n/N	组0 n/N	差值百分点	p	BH q
业务能力高差距	29/91	37/71	-20.2	0.0104	0.1251
财务能力高差距	22/91	20/71	-4.0	0.5916	0.7888
管理能力高差距	21/91	24/71	-10.7	0.1581	0.3798
数据能力高差距	28/91	29/71	-10.1	0.1899	0.3798
风险能力高差距	22/91	27/71	-13.9	0.0608	0.3273
数智课程高需求	89/91	67/71	3.4	0.4057	0.6086
跟岗进入前三	74/91	51/71	9.5	0.1876	0.3798
无系统评估	42/91	43/71	-14.4	0.0818	0.3273
制度落实到位	19/91	13/71	2.6	0.8426	0.8426
常态化轮岗	24/91	14/71	6.7	0.3548	0.6083
人员配置不足	45/91	37/71	-2.7	0.7539	0.8224
培训经费前两档	63/91	47/71	3.0	0.7357	0.8224

制度落实3项

比较方向 有制度且落实到位 减 其他回答

结局	组1 n/N	组0 n/N	差值百分点	p	BH q
无系统评估	9/32	76/130	-30.3	0.0028	0.0083
缺乏培训后跟踪	20/32	88/130	-5.2	0.6760	0.6760
激励结果运用障碍	22/32	74/130	11.8	0.2369	0.3554

Q11可用性6项

比较方向 Q11总人数有效 减 其余答卷

结局	组1 n/N	组0 n/N	差值百分点	p	BH q
三级类别	83/98	62/64	-12.2	0.0166	0.0249
管理者	64/98	27/64	23.1	0.0057	0.0114
硕士及以上	45/98	46/64	-26.0	0.0012	0.0067
高级职称	55/98	20/64	24.9	0.0022	0.0067
财审专业	89/98	53/64	8.0	0.1478	0.1774
数智课程高需求	94/98	62/64	-1.0	1.0000	1.0000

质量核查与复现路径

检查	结果
输入结构	同批答卷 162 份；数值版207列，文本版129列；47题
对齐键	两份序号均唯一，按序号对齐；不发布序号
题目字段跨导出核验	32562 格；不一致 0 格
主样本	保留全部162份；Q11、Q12选答缺失不整行剔除
Q14 多选完整性	每份选择 1 至 3 项；零项 0 份；超上限 0 份
Q17 多选完整性	每份选择 1 至 7 项；零项 0 份；超上限 0 份
Q18 多选完整性	每份选择 1 至 7 项；零项 0 份；超上限 0 份
Q19 多选完整性	每份选择 1 至 4 项；零项 0 份；超上限 0 份
Q21 多选完整性	每份选择 1 至 6 项；零项 0 份；超上限 0 份
Q23 排序约束	162/162 份恰含唯一名次1、2、3
Q25 排序约束	162/162 份恰含唯一名次1、2、3
Q28 多选完整性	每份选择 1 至 6 项；零项 0 份；超上限 0 份
Q30 多选完整性	每份选择 1 至 4 项；零项 0 份；超上限 0 份
Q37 多选完整性	每份选择 1 至 4 项；零项 0 份；超上限 0 份
Q38 排序约束	162/162 份恰含唯一名次1、2、3
Q44 多选完整性	每份选择 1 至 3 项；零项 0 份；超上限 0 份
Q45 多选完整性	每份选择 1 至 3 项；零项 0 份；超上限 0 份
Q46 多选完整性	每份选择 1 至 3 项；零项 0 份；超上限 0 份
Q28并选核查	尚无合作与具体合作形式同时选择 3 份，标为潜在矛盾，主分析保留
Q30并选核查	尚无系统评估与具体评价方式同时选择 7 份，可能为零散评价未成体系，不判定完全没有评价
59个量表子项	小于300秒 2 份；所有量表同分 5 份；合并标记 6 份，仅用于敏感性
Q11总人数有效性	有效 98 份，其余 64 份；后者包含空白和非数值，不等于整题空白

公开附件包含聚合表、统计工作簿、分析脚本、图表及生成报告脚本。数据字典标注每个问题及子项在数值版Sheet1的列范围；Excel第2至163行为162份答卷。原始输入不包含在复现包中，需由数据持有人自行在本地指定。

复现主入口：analyze.py读取两个原始导出，输出aggregate_tables.json和CSV；build_report.py根据聚合JSON生成Word与PDF。完整重算需要Python、pandas、numpy、scipy、openpyxl、python-docx、reportlab、matplotlib及中文字体。工作簿由单独JS生成器从相同聚合JSON生成。

已完成两版本32562格交叉核验，并由独立脚本直接解析XLSX的XML验证相同字段与关键计数。本报告所有公开计数均从本版脚本输出；参考模板仅作结构参考。公开版不包含输入文件、逐人数据、实际IP、时间戳、原始序号或可识别开放原文。